ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Psikedelik Maddeler, Ruh Sağlığı ve Psikoloji

Depresyon, travma ve bağımlılıkta yeni bir dönem — bilimsel, dengeli ve erişilebilir bir bakış

6 Modül · Bilgilendirme ve akademik eğitim amaçlıdır · Temmuz 2026

Program İçeriği

Altı modül, girişten yasal duruma kadar

1

MODÜL 1

Giriş

Tanımlar, tarihçe ve "psikedelik rönesans"

2

MODÜL 2

Maddeler ve Beyin

Nasıl çalışırlar? Serotonin, DMN, nöroplastisite

3

MODÜL 3

Ruh Sağlığı

Depresyon, PTSD, bağımlılık — klinik araştırmalar

4

MODÜL 4

Terapötik Model

Set, setting ve entegrasyon

5

MODÜL 5

Riskler ve Etik

Güvenlik, kontrendikasyonlar, etik sorunlar

6

MODÜL 6

Yasal Durum

Dünya, Türkiye ve sorumlu katılım

Önemli Yasal ve Etik Uyarı

- Bu program yalnızca bilgilendirme ve akademik eğitim amaçlıdır — tıbbi ya da psikolojik tedavi tavsiyesi değildir.
- Herhangi bir maddenin temini, üretimi veya kullanımına ilişkin pratik talimat vermez ve kişisel kullanımı teşvik etmez.
- Türkiye'de psilosibin, LSD, MDMA ve benzeri maddeler yasa dışıdır (TCK md. 188 ve 191); bulundurma, kullanma ve satış hapis cezası dahil ciddi yaptırımlara tabidir.
- Anlatılan klinik uygulamalar yalnızca ilgili maddelerin yasal olduğu ülkelerde, ruhsatlı kurumlarda ve etik kurul onaylı protokollerle yürütülür.
- Ruhsal sıkıntı yaşayan kişiler yetkili bir ruh sağlığı uzmanına başvurmalıdır.

MODÜL

1

Psikedeliklere Giriş

Tanımlar, tarihçe ve "psikedelik rönesans"

- "Psikedelik" ne demek ve hangi madde grupları var?
- Ritüel kullanımdan modern bilime uzanan tarih
- Yükseliş, yasaklama ve yeniden canlanma

Tek tip madde değil: dört grup

"Psikedelik" = zihni açığa çıkaran (psyche + delein). Ama kimyasal ve klinik olarak farklı gruplar vardır:

K

Klasik psikedelikler

Serotonin sistemini etkiler.
LSD, psilosibin, DMT, meskalin

E

Entaktojenler

Yoğun duygusal açıklık ve güven.
MDMA ("ecstasy")

D

Disosiyatifler

Bilinci bedenden ayrıştırır.
Ketamin (tıpta anestezik)

+

Atipik / diğer

Kendine özgü profiller.
Ibogaine, salvia

Not: Bu maddeler tek bir bütün oluşturmaz — "psikedelik terapi" dendiğinde çoğu zaman çok farklı yaklaşımlardan söz ediliyordur.

Umut, yasak ve yeniden doğuş



Ritüel kullanım

Mantar, peyote, ayahuasca — topluluk ve anlam çerçevesinde binlerce yıl

LSD sentezlenir

Hofmann; 1943'te psikoaktif etkisi keşfedilir

Bilim çağı

1000+ makale; alkolizmden kaygıya birçok denemede araştırılır

Yasaklama

ABD'de en katı kategoriye alınır; araştırmalar durur (~30 yıl)

"Rönesans"

Johns Hopkins, Imperial, NYU — sıkı etik çerçevede yeniden başlar

Neden şimdi? Ruh sağlığında büyük bir karşılanmamış ihtiyaç — mevcut antidepresanlar birçok hastaya yetmiyor.

MODÜL

2

Maddeler ve Beyin

Nasıl çalışıyorlar?

- Ana maddelerin kısa profili
- Serotonin 5-HT2A, varsayılan mod ağı, nöroplastisite
- MDMA ve ketamin neden farklı?

Ana maddelerin kısa profili

P

Psilosibin

Mantarlarda doğal; 4–6 saat; en çok çalışılan klasik psikedelik

L

LSD

Çok güçlü, sentetik; etki 8–12 saat; benzer mekanizma

D

DMT / Ayahuasca

DMT kısa ama yoğun; ayahuasca ile saatlere uzar

M

MDMA

Algıdan çok duygusal yakınlık ve güven; travma çalışmalarına ilgi

K

Ketamin

Farklı sistem (glutamat); depresyonda yasal ve onaylı

Önemli ayrım

- Klasik psikedelikler bağımlılık yapan "ödül" devrelerini aynı şekilde tetiklemez — fiziksel bağımlılık yapıcı sayılmazlar.
- Ancak "bağımlılık yapmaz" ≠ "risksiz". Psikolojik riskler gerçektir (Modül 5).
- MDMA ve ketamin ayrı ele alınır: farklı mekanizma, farklı etki, farklı yasal statü.

Beyinde ne oluyor?

5-HT2A

Serotonin reseptörü

Klasik psikedeliklerin ortak imzası: beynin belirli bölgelerinde alışılmadık bir aktivasyon başlatır.

DMN

Varsayılan mod ağı

"Benlik" ve alışkanlığa dönüşmüş düşünce kalıplarıyla ilişkili ağ geçici olarak gevşer.

⟳

Nöroplastisite

Beyin bir süre "değişime açık" kalır — bu yüzden entegrasyon (sonraki çalışma) kritiktir.

Öznel deneyim

Sık bildirilenler: algısal değişimler · duygusal açılma · "ego çözülmesi" · anlam ve içgörü hissi. Bu anlam dolu deneyimlerin yoğunluğu ile klinik iyileşme arasında bir ilişki olabilir — ama mekanizma hâlâ tartışmalı ve aktif araştırma konusu.

MODÜL

3

Psikedelikler ve Ruh Sağlığı

Klinik araştırmalar

- Depresyon, PTSD, yaşam sonu kaygısı, bağımlılık
- Ketamin/esketamin: bugün yasal olan seçenek
- Kanıtların gücü ve sınırları

Hangi alanlarda araştırılıyor?

1

Depresyon

Tedaviye dirençli depresyonda psilosibin (COMP360) Faz 3 hedefine ulaştı (2025–26)

2

PTSD

MDMA destekli terapi; korkuyu yumuşatıp travmayla yüzleşmeyi kolaylaştırır

3

Yaşam sonu kaygısı

İlerlemiş kanserde kaygı ve umutsuzlukta belirgin, uzun süreli azalma

4

Bağımlılık

Sigara ve alkol bırakmada umut verici (henüz kesin olmayan) sonuçlar

5

Ketamin / esketamin

Spravato: tedaviye dirençli depresyonda ONAYLI; etki bazen 24 saatte

Ortak hedef: mevcut yöntemlere yanıt vermeyen "zor" vakalar.

Umut ile temkin arasında

2024 FDA, MDMA (PTSD) başvurusunu onaylamadı — ek deneme istedi

2025–26 Psilosibin (COMP360) olumlu Faz 3; ilk FDA onayına yakın

Bugün Ketamin/esketamin zaten yasal ve onaylı

Kanıtları neden temkinle okumalı?

- Örneklem küçük: birçok erken çalışma az katılımcıyla; alan hâlâ genç.
- Körleme sorunu: hastanın gerçek madde mi plasebo mu aldığını gizlemek çok zor.
- Madde mi, terapi mi? İyileşmenin ne kadarı maddeye, ne kadarı desteğe bağlı — ayırmak güç.
- Beklenti yanlılığı ve "mucize çözüm" değil: belirli gruplar, kontrollü koşullar için.

MODÜL

4

Terapötik Model

Set, setting ve entegrasyon

- "İlaç değil, süreç" yaklaşımı
- Set (zihinsel hazırlık) ve setting (ortam)
- Zor deneyimler ve entegrasyonun önemi

İlaç değil, süreç: üç aşama

1

Hazırlık

Güven ilişkisi, hastanın geçmişi ve niyeti, ne beklenebileceği, zor anlarla baş etme planı. Güvenliğin temeli.

2

Deneyim seansı

Denetimli, destekleyici ortamda saatlerce eşlik. Non-direktif: yönlendirme değil, güvende tutma.

3

Entegrasyon

Yaşananları günlük hayata taşıma. En kritik ve en çok ihmal edilen aşama — içgörüyü kalıcı değişime çevirir.

Set & Setting

Set = kişinin iç dünyası (ruh hâli, niyet). Setting = fiziksel ve sosyal ortam. Deneyimin niteliği büyük ölçüde maddeye değil bu iki bağlama bağlıdır — kontrolsüz ortamın neden riskli olduğunu da bu açıklar.

MODÜL

5

Riskler, Güvenlik ve Etik

Alanın en hassas noktası

- Fiziksel ve psikolojik riskler
- Kontrendikasyonlar ve ilaç etkileşimleri
- Etik sorunlar ve ticarileşme

Riskler ve kimler için sakıncalı

△ Başlıca riskler

- Yoğun korku/panik; kontrolsüz ortamda travmatik olabilir
- Uzamış olumsuz etkiler (günler–haftalar kaygı)
- HPPD: nadir, süregelen algı bozuklukları
- Kan basıncı/kalp hızında artış; MDMA'da ısı ve sıvı dengesi riski
- Yargı bozulması → kaza riski

× Kimler için sakıncalı (kontrendikasyon)

- Psikoz / bipolar öyküsü (kişisel veya güçlü aile öyküsü) — atak tetikleyebilir
- Bazı kalp-damar hastalıkları
- İlaç etkileşimleri: bazı antidepresanlar; MAOI + MDMA hayati tehlike
- Gebelik ve bazı nörolojik durumlar

Kontrolsüz kullanım tam da bu risk faktörleri bilinmeden yapıldığı için tehlikelidir.

Etik: savunmasızlık ve güç dengesizliği

T

Telkine yatkınlık

Hasta, terapistin inanç ve beklentilerinden aşırı etkilenebilir; dünya görüşü "aşılama" riski

S

Sınır ihlalleri

Savunmasız durumda dokunma ve mahremiyet kritik; geçmiş istismar vakaları katı protokolleri zorunlu kıldı

L

Lykos / MDMA dersi

FDA reddinin arkasında etik ihlaller ve eksik raporlama vardı: "sonuç iyiyse yöntem önemsizdir" kabul edilemez

$

Ticarileşme

Yüksek maliyet ve eşitsizlik; geleneksel bilginin sahiplenilmesi; "hızlı çözüm" pazarlaması

MODÜL

6

Yasal Durum ve Gelecek

Dünya, Türkiye ve sorumlu katılım

- Dünyada değişen tablo (ABD, Avustralya, Avrupa)
- Türkiye: yasal durum
- Sorumlu ve yasal yol

Hızla değişen yasal tablo

ABD

ABD

Federal yasak sürüyor ama hareketli: MDMA 2024'te reddedildi; psilosibin onayın eşiğinde; 2026 hızlandırma; Oregon/Colorado eyalet modelleri

Avustralya

Avustralya

Dünyada ilk: 2023'ten beri yetkili psikiyatristler PTSD için MDMA, dirençli depresyon için psilosibin reçete edebiliyor

Avrupa

Avrupa

Karışık: çoğu ülkede katı yasak; artan araştırma ve ketamin klinikleri; temkinli açılım

TR

Türkiye

- **Psilosibin, LSD, MDMA yasa dışıdır.**
- TCK md. 191: kullanma/bulundurma suç. TCK md. 188: imal/ticaret çok daha ağır ceza.
- Ketamin sadece hekim denetiminde, ruhsatlı endikasyonda kullanılabilir.
- Bu alan Türkiye'de yalnızca akademik/mesleki ilgi konusudur — pratik uygulama değil.

SONUÇ

Sorumlu yol: merakla ama temkinle

1

Bilim okuryazarlığı

Güvenilir akademik kaynakları takip et; abartıyla ciddi araştırmayı ayırt et

2

Yasalara saygı

Türkiye'de bu maddeler yasa dışı; ilgi, hukuka aykırılığı meşrulaştırmaz

3

Eleştirel ve etik bakış

Potansiyeli, riskleri ve etik sorunları birlikte gör

4

Profesyonel destek

Kişisel sıkıntıda denetimsiz maddelere değil, yetkili uzmana yönel

Bu program bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi/psikolojik tavsiye değildir ve yasa dışı madde kullanımını önermez. · Temmuz 2026